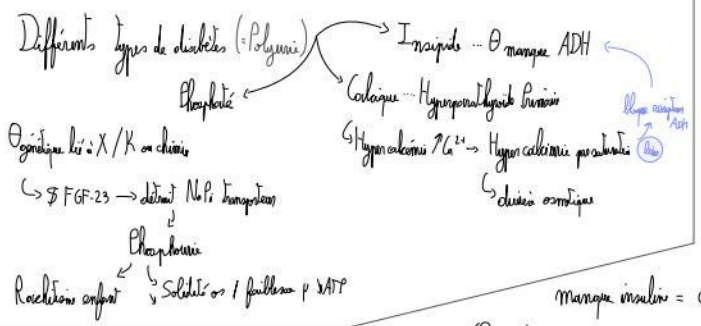
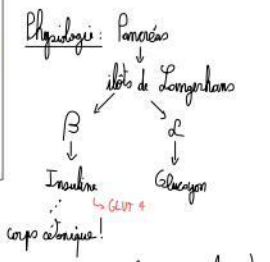




Diabète Sucre

Pathologie diag



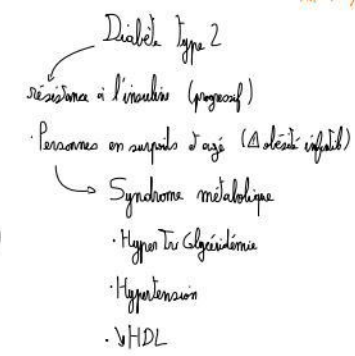
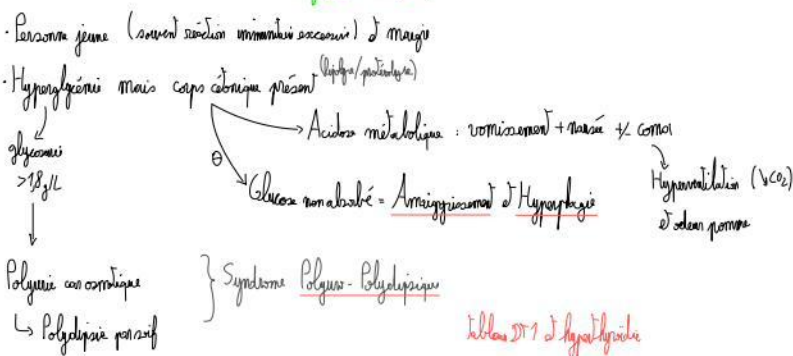
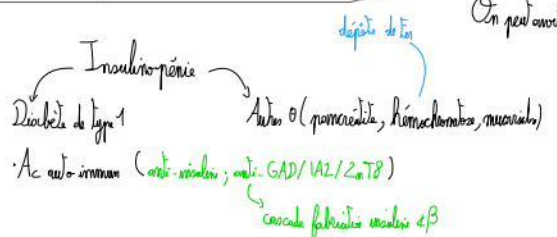
Glycémie $\approx 1g/L$
 Glycosurie $= 0g/L$
 SGLT... tout est réabsorbé

$\rightarrow$ si Glycémie $> 2g/L$ (11.1 mmol/L)
 ou $2 \times$ glycémie à jeun $> 12.6g/L$ (7 mmol/L)
 ou HGPO $\hookrightarrow$ glycémie après 2h $> 2g/L$
 [non validé France] ou Hb glycosylé HbA1c $> 6,5\%$

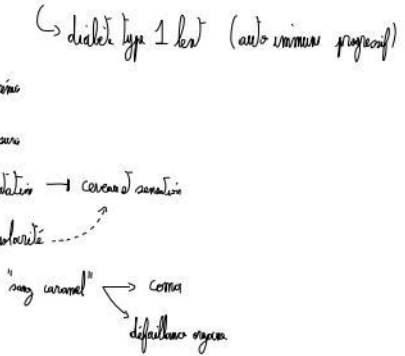
Cas particuliers

diabète gestationnel
 si glycémie à jeun $> 0,92g/L$
 ou HGPO (75g glucose)
 $\hookrightarrow$ 1h $> 1,8g/L$ ou 2h $> 1,5g/L$

diabète pré-diabétique
 - Hyperglycémie modérée à jeun (11-12.6 g/L)
 - Intolérance glucosée
 $\hookrightarrow$ test HGPO $\rightarrow$ [1.4-2 g/L] après 2h



LADA



II: Injection d'insuline

si acido-cétose diabétique $\rightarrow$ insuline + glucose jusqu'à θ cétose

Hypoglycémie chronique

4.1010 biochimiques

→ Surcharg. chaine respi (↑ Glucose → ↑ Acide/L → blocage complex 3 (O₂)
 → Voe des polyols (glucose → -NADPH → Sorbitol) → Stress osmotique
 → Stress oxydatif

Stress oxydatif

Dysfonctionnement endothélial / inflammation / Dysrégulation cellulaire

proliferat capillaire plan de glucose
 dégradation → micro aneurysme

Microvasculature

→ Œil

• Maculopathie diabétique

Partie postérieure
 Réception orthokélat

compromis photoréception = vision acuité visuelle (BAV)

• Rétinopathie = le reste de la rétine

occlusion = micro aneurysmes (dilatation capillaire)

Reins

Néphropathie

↑ P. Dérivés

AGE → sont généralement présents

nodules coronaires (point blanc)

hémorragie

ischémie

\$VEGF → néovascularisation



macula = tache jaune avec l'ap de photoréception et de cones (vision précise)

Pied diabétique de Charcot = ostéoarthropathie diabétique (affection du tissu plantaire en inflammation)

Macrovasculaire

AVC → recherche soufflet cardiaque

IDM → coronaropathie

Membres inférieurs → ulcères, plaies, infections, ischémie

microvasculaire

Neuropathie diabétique

(ischémie démyélinisation)
 atrophie msc

Atteinte sensorimotrice (mono/polyneuropathie)

Paséo = petites fibres amyéliniques

• bilatérale symétrique, en gant et en bas

• perte chaud/froid et perte douleur = hyposensibilité

Tardif = grosses fibres myélinisées

• Anxiété sensible

↳ Risque: ne pas sentir quand on se brûle

↳ Neuropathie + Arthropathie = auto-lesion

↳ blessure = risque sepsis d'amputation

Hypoglycémie
 < 0,5 g/L normal
 < 0,7 g/L si diabétique

Sueurs, tremblements (signes hormonaux d'hyperglycémie)

↳ diplopie, parosmies légères (dysfonctionnement)

↳ coma (sueurs profuses)

PARMI CES COMPLICATIONS ON RETROUVE		
HÉMORRAGIES INTRA-VITRÉENNES		
DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE (TRACTIONNEL)		
GLAUCOMES NÉOVASCULAIRES	La pression monte ce qui induit un glaucome car les nouveaux vaisseaux bouchent la sortie du liquide	